

//Раздел №1. Сахарный диабет: ИД-1 ОПК-4;ИД-3 ОПК-4; ИД-3 ОПК-5;ИД-2 ОПК-7; ИД-3 ПК-1;ИД-4 ПК-1; ИД-2 ПК-2;ИД3 ПК3.

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ:

{
~%33.33333%в цельной венозной крови
~%33.33333%в цельной капиллярной крови
~%33.33333%в плазме венозной крови
~%-50%в плазме артериальной крови
~%-50%в межклеточной жидкости
}

ТРЕБУЮТ УЧЕТА СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ БОЛЬНОГО
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРОДУКТЫ:

{
~%33.33333%картофель
~%-50% огурцы
~%33.33333%молоко
~%33.33333%крупы и макаронные изделия
~%-50% помидоры
}

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ:

{
~%33.33333%гипогликемические состояния
~%-50% кетоацидоз
~%33.33333%постинсулиновые липодистрофии
~%-50% синдром Нобекура
~%33.33333%синдром Сомоджи
}

К ВОЗМОЖНЫМ ПРИЧИНАМ РАЗВИТИЯ ГИПОГЛИКЕМИИ ОТНОСЯТСЯ:

{
~%-50% недостаточная доза инсулина
~%33.33333%недостаточное количество углеводов в рационе
~%33.33333%прием алкоголя
~%33.33333%физическая нагрузка
~%-50% инфекционные заболевания
}

К ПОКАЗАНИЯМ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСЕНАТИДА ОТНОСЯТСЯ:

- {
- ~%50% в комбинации с метформином при сахарном диабете 2 типа с ожирением
- ~%50% в комбинации с препаратами сульфонилмочевины при сахарном диабете 2 типа с ожирением
- ~%-33.33333% в комбинации с инсулинотерапией при сахарном диабете 2 типа с ожирением
- ~%-33.33333% сахарный диабет ассоциированный с заболеваниями ЖКТ, сопровождающимися гастропарезом
- ~%-33.33333% в комбинации с препаратами из группы ДПП-4
- }

К ОСНОВНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА-ЛПВП ОТНОСЯТСЯ:

- {
- ~%33.33333%снижение веса
- ~%-50% занятия профессиональным спортом
- ~%33.33333%отказ от курения
- ~%33.33333%медикаментозная терапии
- ~%-50% отказ от жирной пищи
- }

К ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ ОТНОСЯТСЯ:

- {
- ~%33.33333%диабетическая ретинопатия
- ~%33.33333%диабетическая катаракта
- ~%-50% блефарит
- ~%-50% эндокринная офтальмопатия
- ~%33.33333%транзиторное нарушение остроты зрения при значительных колебаниях гликемии
- }

В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ИГРАЮТ РОЛЬ:

- {
- ~%33.33333%нарушение углеводного обмена
- ~%33.33333%нарушение липидного обмена
- ~%33.33333%нарушение окислительно-восстановительных процессов в сетчатке
- ~%-50% несостоятельность связочно-капсулярного аппарата хрусталика
- ~%-50% наследственность
- }

ДЛЯ ИНСУЛИНА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

- {
- ~%-33.33333% усиление процессов утилизации аминокислот
- ~%50% способствует улучшению утилизации глюкозы
- ~%50%торможение липолиза
- ~%-33.33333%усиление глюконеогенеза
- ~%-33.33333% усиление процессов утилизации жирных кислот
- }

К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ЭКСЕНАТИДА ОТНОСЯТСЯ:

- {
- ~%33.33333%стимуляция секреции инсулина
- ~%33.33333%увеличение неогенеза β -клеток и ингибирование апоптоза β -клеток
- ~%33.33333%подавление повышенной секреции глюкагона
- ~%-50% ускорение эвакуации пищи из желудка
- ~%-50% повышает аппетит
- }

К НАРУШЕНИЮ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУСЯ КАК «ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ДИСЛИПИДЕМИЯ» ОТНОСЯТСЯ:

- {
- ~%-50% повышение уровня общего холестерина
- ~%33.33333%гипертриглицеридемия
- ~%33.33333%повышение уровня ЛПНП
- ~%33.33333%снижение концентрации ЛПВП
- ~%-50% повышение ЛПВП
- }

ВЫБОР ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ{

- ~%33.33333%достижением компенсации сахарного диабета
- ~%33.33333%учетом вида сахароснижающей терапии
- ~%33.33333%характером дислипидемии
- ~%-50% весом пациента
- ~%-50% наличием сопутствующих заболеваний
- }

ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВИТРЕКТОМИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- {
- ~%33.33333%массивный, длительно нерассасывающийся гемофтальм
- ~%33.33333%отслойка сетчатки на единственном видящем глазу
- ~%33.33333%свежее кровоизлияние в стекловидное тело
- }

~%-50% тракционная отслойка сетчатки
~%-50% кровоизлияние в сетчатку
}

Для уровня глюкозы крови используются:

{
~%-50%глюкометр
~%33.33333%помповый дозатор
~%-50%системы непрерывного мониторинга гликемии
~%33.33333%калиперометр
~%33.33333%тонометр
}

Перечислите инсулины длительного действия

{
~%-33.33333%НовоРapid
~%50%Левемир
~%50%Лантус
~%-33.33333%Апидра
~%-33.33333%Лизпро
}

Осложнения, наиболее часто развивающиеся при СД1 у детей и подростков

{
~%-50%макроангиопатия
~%33.33333%нефропатия
~%33.33333%катаракта
~%33.33333%нейропатия
~%-50%глаукома
}

Основными причинами снижения зрения у пациентов с сахарным диабетом являются

{
~%-33.33333%непролиферативная
~%-33.33333%препролиферативная
~%-33.33333%диабетическая ретинопатия на всех стадиях
~%50%пролиферативная диабетическая ретинопатия
~%50%диабетический макулярный отек
}

С целью проведения медицинской реабилитации пациентам с синдромом диабетической стопы рекомендуется

- {
- ~%-50% согревание ног грелкой
- ~%-50% реваскуляризация нижних конечностей
- ~%33.33333%обязательная консультация ортопеда после заживления раневых дефектов
- ~%33.33333%подбор индивидуального ортопедического пособия (терапевтическая обувь, иммобилизирующей разгрузочной повязки, изготовление тьютора или отреза, пошив индивидуальной ортопедической обуви)
- ~%33.33333%обучение пациентов и членов их семей правилам ухода за ногами, а при наличии раневого дефекта - правилам смены повязки и уходу за кожей пораженной конечности
- }

С целью проведения медицинской реабилитации пациентам с диабетической ретинопатией (пациентам со слабовидением) рекомендуется

- {
- ~%50% подбор очков, в том числе с дополнительным увеличением и встроенными монокулярами
- ~%50% подбор специальных средств для получения информации для инвалидов с нарушением зрения
- ~%-33.33333% хирургическое лечение
- ~%-33.33333% лазерное лечение
- ~%-33.33333% фитотерапия
- }

В перечень реабилитационных мероприятий пациентам с сахарным диабетом 1 типа могут быть включены

- {
- ~%33.33333%занятия с медицинским психологом
- ~%33.33333%социальная адаптация с участием специалистов и социальных работников
- ~%33.33333%санаторно-курортное лечение в отсутствие значимой метаболической декомпенсации и без выраженных стадий осложнений
- ~%-50% санаторно-курортное лечение при наличии выраженных стадий осложнений сахарного диабета
- ~%-50% фитотерапия
- }

Что можно отнести к изменениям глазного дна при диабетической ретинопатии?

{
~%33.33333%твердые экссудаты
~%-50%макулярную дегенерацию
~%33.33333%пролиферацию
~%33.33333%микроаневризм
~%-50%венозную аномалию
}

Что включает в себя профилактика диабетической ретинопатии?

{
~%33.33333%компенсацию углеводного обмена
~%33.33333%лечение дислипидемии
~%33.33333%лечение артериальной гипертензии
~%-50%назначение ангиопротекторов
~%-50%витрэктомия
}

Что относится к обязательным методам обследования пациентов с диабетической ретинопатией?

{
~%33.33333%определение остроты зрения
~%33.33333%измерение внутриглазного давления
~%-50%биомикроскопия хрусталика и стекловидного тела
~%33.33333%когерентная оптическая томография
~%-50%офтальмоскопия с расширением зрачка
}

Что относят к диабетическим нейропатиям?

{
~%-33.33333%торакоабдоминальная нейропатия
~%-33.33333%сакральная плексопатия
~%50%дистальная полинейропатия
~%50%моторная нейропатия
~%-33.33333%туннельные нейропатии
}

Что относят к клиническим проявлениям диабетической полинейропатии?

{
~%33.33333%колющие боли
~%-50%судороги
~%33.33333%онемение

~%33.33333%генерализованная мышечная слабость
~%-50%невозможность удерживать мелкие предметы
}

Какие параметры рекомендуются пациентам с диабетической нефропатией на гемодиализе?

{
~%-33.33333%НbA1c<8,0%
~%50%АД 130/80 – 140/90 мм рт. ст.
~%-33.33333%НbA1c<6,0%
~%-33.33333%уровень гемоглобина ≥ 110 г/л, но ≤ 120 г/л
~%50%общий кальций – 2,1-2,37 ммоль\л
}

Перечень реабилитационных мероприятий для пациентов с сахарным диабетом 2 типа включает

{
~%33.33333%занятия с медицинским психологом
~%33.33333%отдых в специализированных санаториях
~%33.33333%социальная адаптация с участием специалистов и социальных работников
~%-50%фитотерапия
~%-50%ЛФК
}

//Раздел№2 Заболевания Щитовидной железы- ИД-3 ОПК-4; ИД-3 ОПК-5; ИД3 ОПК 6;ИД-2 ОПК-7; ИД-3 ПК-1;ИД 1 ПК1;ИД-4 ПК-1; ИД-2 ПК-2;ИД3 ПК3.

К КЛИНИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ГИПОТИРЕОЗА ОТНОСЯТСЯ

{
~%-33.33333% значительная потеря в массе тела
~%50% отсутствие специфичных (встречающихся только при гипотиреозе) симптомов
~%50% преимущественно обратимый характер изменений внешности больных при гипотиреозе
~%-33.33333% отсутствие выраженного ожирения на фоне дефицита тиреоидных гормонов
~%-33.33333% ожирение
}

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- {
- ~%33.33333%склонность к запорам
- ~%-50% повышение аппетита, способствующее увеличению веса
- ~%33.33333%дискинезия желчевыводящих путей
- ~%33.33333%развитие В12-дефицитной анемии
- ~%-50% метеоризм
- }

ДЛЯ ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНО

- {
- ~%50% крупный вес при рождении
- ~%-33.33333% повышение мышечного тонуса
- ~%-33.33333% метеоризм, стойкая диарея
- ~%50% запоры
- ~%-33.33333% повышение аппетита
- }

ДЛЯ ПОДОСТРОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНЫ

- {
- ~%33.33333%боль в горле с иррадиацией в затылок, уши, нижнюю челюсть
- ~%33.33333%субфебрилитет
- ~%-50%повышение СОЭ, лейкоцитоз
- ~%33.33333%клиника легкого тиреотоксикоза
- ~%-50% эритроцитоз
- }

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- {
- ~%33.33333%радиойодаблации
- ~%33.33333%супрессивной терапии L-тироксином
- ~%-50% лечении тиреостатиками
- ~%33.33333%радикальной тиреоидэктомии
- ~%-50% лечение тиреостатиками
- }

ПОРАЖЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

{

~%33.33333%развитием рабдомиопатии
~%33.33333%генерализованной гипертрофией скелетной мускулатуры
~%33.33333%умеренной мышечной слабостью и медлительностью
~%-50% ускорением костного ремоделирования
~%-50% отсутствие мышечного тонуса
}

К ОТЛИЧИЯМ ВТОРИЧНОГО И ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ОТНОСИТСЯ:

{
~%33.33333%частое отсутствие увеличения веса
~%33.33333%изменение кожных покровов (тонкая, сухая кожа)
~%33.33333%развитие аменореи
~%-50% снижение Т4
~%-50% постоянная слабость и апатия
}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЦИНТИГРАФИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

{
~%33.33333%дифференциальная диагностика болезни Грейвса и функциональной автономии щитовидной железы
~%33.33333%диагностика компенсированной функциональной автономии щитовидной железы
~%-50%подтверждение злокачественного характера узловых образований щитовидной железы
~%33.33333%диагностика деструктивного тиреотоксикоза
~%-50% подтверждение диагноза аутоиммунного тиреоидита
}

Укажите препараты, используемые для подавления функции щитовидной железы:

{
~%-50%тиамазол
~%-50%пропицил
~%33.33333%перхлорат калия
~%33.33333%глибенкламид
~%33.33333%карбонат лития
}

В комплексе лечения тиреотоксического криза применяются:

{
~%33.33333%тиреостатики

~%33.33333%β-блокаторы
~%33.33333%глюкокортикоиды
~%-50%гормон роста
~%-50%Л-тироксин
}

Для терапии аутоиммунного тиреоидита применяют:

{
~%50%L-тироксин
~%-33.33333%Минирин
~%-33.33333%Кортинефф
~%50%Эутирокс
~%-33.33333%тиреостатики
}

Факторы, понижающие уровень кальция в крови:

{
~%33.33333%кальцитонин
~%33.33333%паратгормон
~%-50%глюкагон
~%33.33333%фосфаты
~%-50%витамин Д
}

Перечислите болезни щитовидной железы:

{
~%-33.33333% врожденная гиперплазия надпочечников
~%50%ьболезнь Грейвса
~%-33.33333% болезнь Иценко-Кушинга
~%50%тиреотоксикоз
~%-33.33333%акромегалия
}

Изменения со стороны нервной системы при диффузно-токсическом зобе:

{
~%33.33333%усиление сухожильных рефлексов
~%33.33333%хореиформный гиперкинез
~%33.33333%появление тремора конечностей
~%-50%нарушение двигательной и трофической функций, снижение чувствительности
~%-50%нейропатия

}

Перечислите симптомы, характерные для болезни Грейвса:

{

~%33.33333%эндокринная офтальмопатия, появление выпячивания глазных яблок наружу, отека тканей вокруг глаза, неполного смыкания век, более при движении глазных яблок и пр.

~%33.33333%дрожание рук, тремор, мышечная слабость, быстрая утомляемость, возбудимость, плаксивость

~%33.33333%появление аритмии, учащение пульса, тахикардии, дополнительных сокращений сердца, экстрасистол, гипертонии

~%-50%ожирение

~%-50%сухость кожных покровов

}

Критерии излечения ДТЗ:

{

~%33.33333%состояние эутиреоза

~%33.33333%уровень свТ3 и свТ4 в пределах нормы

~%-50%уменьшение размеров щитовидной железы

~%-50%нормогликемия

~%33.33333%отсутствие антител к рТТГ

}

Для доброкачественного образования щитовидной железы по данным УЗИ наиболее характерны следующие признаки

{

~%33.33333%овальная форма

~%-50%интранодулярный кровоток

~%33.33333%четкий контур

~%33.33333%гиперэхогенность

~%-50%увеличение регионарных лимфоузлов

}

Закономерности распространенности хронического аутоиммунного тиреоидита в детском возрасте

{

~%33.33333%имеет низкую частоту у детей до наступления

~%-50%пубертатного периода и на фоне полового созревания отмечается рост заболеваемости имеет повышенную частоту у детей до наступления пубертатного периода и на фоне полового созревания отмечается снижение заболеваемости

~%33.33333%встречается чаще у девочек
~%-50%встречается чаще у мальчиков
~%33.33333%у детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, частота встречаемости составляет 30–40 %
}

Какие препараты могут использоваться при лечении тиреотоксикоза?

{
~%33.33333%тиреостатики
~%33.33333%бета – блокаторы
~%33.33333%глюкокортикоиды
~%-50%симпатолитики центрального действия (моксонидин, резерпин)
~%-50%седативные средства
}

Что является показанием к хирургическому лечению Болезни Грейвса (диффузного токсического зоба)?

{
~%50%диффузного токсического зоба средней и тяжелой формы при отсутствии стойкого эутиреоидного состояния после медикаментозного лечения
~%50%диффузного токсического зоба больших размеров
~%-33.33333%загрудинных форм токсического зоба
~%-33.33333% диффузного токсического зоба, осложненного аритмией
достижения не только клинической, но и иммунологической ремиссии
~%-33.33333%диффузного токсического зоба на фоне медикаментозного лечения
}

Какие препараты могут использоваться для лечения подострого тиреоидита Де Кервена?

{
~%33.33333%Преднизолон
~%-50% Мерказолил
~%33.33333%Ксефокам
~%-50%Левотироксин
~%33.33333%Пропранолол
}

//Раздел№3 Заболевания надпочечников- ИД-3 ОПК-4; ИД-3 ОПК-5; ИД3 ОПК 6;ИД-2 ОПК-7; ИД-3 ПК-1;ИД-4 ПК-1; ИД-2 ПК-2; ИД3 ПК3.

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ХАРАКТЕРНО

{

~%33.33333%наличие опухоли коры надпочечников

~%33.33333%артериальной гипертензии

~%33.33333%отсутствие отеков

~%-50% наличие отеков

~%-50% анасарка

}

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ХАРАКТЕРНО

{

~%-50% необходимость постоянной заместительной терапии
глюкокортикоидами

~%33.33333%быстрое восстановление обменных процессов

~%33.33333%нормализация артериального давления

~%33.33333%восстановление массы тела

~%-50% повышение артериального давления

}

ДЛЯ ПРОСТОЙ ВИРИЛЬНОЙ ФОРМЫ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФИНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ХАРАКТЕРНО

{

~%33.33333%женский псевдогермафродитизм

~%33.33333%преждевременное половое развитие мальчиков

~%-50%обезвоживание

~%33.33333%отсутствие гипотонии

~%-50% всегда нормальное строение внутренних гениталий у плодов с женским
генотипом

}

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КОРТИКОСТЕРОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

{

~%33.33333%перераспределение подкожной жировой клетчатки

~%33.33333%атрофия мышц плечевого пояса, ягодичных и бедренных
мышц

~%33.33333%атрофия, истончение кожи и появление стрий

~%-50% увеличение плотности костной ткани

~%-50% уплотнение кожи

}

ДЛЯ КОРТИКОСТЕРОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СО
СТОРОНЫ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ В ВИДЕ

{

~%33.33333%гипергликемии и гиперхолестеринемии

~%33.33333%гипокалиемии

~%33.33333%гипоальбуминемии

~%-50% гипонатриемии

~%-50% гиперкалиемии

}

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ КОРТИКОСТЕРОМЕ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

{

~%-50%повышением уровня адренокортикотропного гормона

~%33.33333%снижением уровня адренокортикотропного гормона

~%33.33333%повышением уровня кортизола в сыворотке крови

~%33.33333%повышением суточной экскреции кортизола с мочой

~%-50% понижение суточной экскреции кортизола с мочой

}

К МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ОТНОСИТСЯ

{

~%50%протонотерапия на область гипофиза

~%50% трансфеноидальное удаление кортикотропиномы

~%-33.33333% обязательная двухсторонняя адреналэктомия

~%-33.33333% лечение аминоглутетемидом

~%-33.33333% прием хлоридов

}

К ПОЧЕЧНЫМ СИМПТОМАМ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА
ОТНОСЯТСЯ

{

~%33.33333%полиурия

~%-50%полифагия

~%33.33333%никтурия

~%33.33333%умеренная протеинурия

~%-50% полидипсия

}

ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ХАРАКТЕРНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ В ВИДЕ

{

~%33.33333%гипертонического криза

~%33.33333%гипокалиемического паралича сердца

~%33.33333%очагового нарушения мозгового кровообращения

~%-50%развития отечного синдрома

~%-50% гипергликемичесеого паралича сердца

}

ДЛЯ ГИПЕРТОНического КРИЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ ХАРАКТЕРНО

{

~%33.33333%резкая головная боль, тошнота, рвота

~%-50%отсутствие тетании, преходящих параличей

~%33.33333%снижение или потеря зрения

~%33.33333%резкое повышение артериального давления (особенно диастолического)

~%-50% отсутствие головной боли

}

У НЕЙРОМЫШЕЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ПРОЯВЛЯЮТСЯ

{

~%33.33333%параличом мышц

~%33.33333%приступами тетании

~%33.33333%приступами резкой мышечной слабости

~%-50%вялыми параличами мышц нижних конечностей

~%-50%потерей сознания

}

ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ХАРАКТЕРНО

{

~%33.33333%увеличение уровня альдостерона крови, увеличение экскреции альдостерона с мочой

~%33.33333%снижение активности ренина крови

~%-50%повышение активности ренина крови

~%33.33333%нормальная суточная экскреция 17-оксикортикостероидов с мочой

~%-50% уменьшение уровня альдостреона в крови

}

ДЛЯ ВТОРИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ХАРАКТЕРНО

- {
- ~%33.33333%наличие отеков
- ~%33.33333%умеренная гипертензия
- ~%33.33333%отсутствие выраженной гипокалиемии
- ~%-50%отсутствие изменений со стороны надпочечников
- ~%-50%снижение уровня ренина крови
- }

ДЛЯ ВТОРИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ПОЧЕЧНОГО ГЕНЕЗА НЕ ХАРАКТЕРНО

- {
- ~%33.33333%повышение уровня ренина в плазме крови
- ~%33.33333%повышение уровня ангиотензина II в плазме крови
- ~%33.33333%повышение уровня альдостерона в плазме крови
- ~%-50%снижение уровня ренина в плазме крови
- ~%-50%повышение кровяного давления
- }

ДЛЯ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ НЕ ХАРАКТЕРНО

- {
- ~%-50%снижение уровня активного ренина в крови
- ~%33.33333%увеличение содержания катехоламинов в крови
- ~%33.33333%увеличение содержания катехоламинов в моче
- ~%33.33333%увеличение в моче метаболитов катехоламинов
- ~%-50% уменьшение содержания катехоламинов в крови
- }

К ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ОТНОСЯТСЯ

- {
- ~%33.33333%удаление альдостеромы одного надпочечника
- ~%33.33333%тотальная резекция надпочечников
- ~%33.33333%тотальная резекция одного надпочечника
- ~%-50%резекция обоих надпочечников при односторонней аденоме
- ~%-50% субтотальная резекция
- }

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ФОРМИРОВАНИЯ АЛЬДОСТЕРОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

{
~%-50% генетические
~%33.33333%иммунологические
~%33.33333%канцерогенные
~%33.33333%неполноценность ферментных систем стероидогенеза в
надпочечниках
~%-50%инфекции
}

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСОБЕННОСТЯМ ТЕЧЕНИЯ
АНДРОСТЕРОМЫ У ДЕВОЧЕК?

{
~%-33.33333%увеличение клитора в пубертатный период
~%50%отставание костного возраста по отношению к
паспортному
~%-33.33333%отсутствие роста молочных желез
~%-33.33333% отсутствие менструаций
~%50% отсутствие роста волос на лобке
}

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ВТОРИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

{
~%33.33333%длительная
терапия глюкокортикоидами неэндокринных заболеваний
~%33.33333%церебрально-гипофизарная недостаточность
~%33.33333%нейроинфекции
~%-50%опухоли почек
~%-50%аутоиммунное поражение кожи
}

При хронической надпочечниковой недостаточности в крови наблюдается:

{
~%50% снижение продукции глюкокортикоидов
~%-33.33333% повышение продукции глюкокортикоидов
~%50% снижение продукции минералокортикоидов
~%-33.33333% повышение продукции минералокортикоидов
~%-33.33333% снижение продукции адреналина и норадреналина
}

Основными клиническими проявлениями острой надпочечниковой недостаточности являются гипертонус:

- {
- ~%33.33333%вялость
- ~%-50% гиперемия кожных покровов
- ~%33.33333%бледность
- ~%-50% мышечная гипотония
- ~%33.33333%гипорефлексия
- }

В понятие АКТГ -зависимого гиперкортицизма включают:

- {
- ~%50% болезнь Иценко-Кушинга
- ~%-33.33333%глюкостерому
- ~%-33.33333%хроническую передозировку гидрокортизона
- ~%50% АКТГ - эктопический синдром
- ~%-33.33333%ожирение, протекающее с гиперкортизолемией
- }

Какие симптомы не характерны для вторичного гипокортицизма?:

- {
- ~%-33.33333%гипогликемия
- ~%50% гиперпигментация кожных покровов
- ~%50% недостаточность минералкортикоидов
- ~%-33.33333%дефицит глюкокортикоидов
- ~%-33.33333%гипертония
- }

Симптомы, характерные для сольтеряющей формы ВГН:

- {
- ~%33.33333%гермафродитное строение гениталий у девочек
- ~%-50% запоры
- ~%33.33333%гиперпигментация крупных складок и ареол
- ~%-50% рвота после еды
- ~%33.33333%жидкий стул
- }

Лабораторными признаками катехоламинового криза являются:

- {
- ~%-33.33333% гипогликемия
- ~%-33.33333% высокий гематокрит

~%50% повышение суточной экскреция метанефринов с мочой
~%50% повышение метанефринов в плазме
~%-33.33333% глюкозурия
}

Причиной ВДКН у детей является

{
~%-33.33333% родовая травма с поражением передней доли гипофиза
~%-33.33333% кровоизлияние в надпочечники во время родов
~%50% наследственная ферментопатия
~%50% гипоплазия коры надпочечников
~%-33.33333% гиперплазия коры надпочечников
}

Феохромоцитома - гормонально активная опухоль, продуцирующая:

{
~%-33.33333% глюкокортикоиды
~%-33.33333% альдостерон
~%-33.33333% андрогены
~%50% адреналин
~%50% норадреналин
}

Симптомы, характерные для простой формы ВГН:

{
~%50% гермафродитное строение гениталий у девочек
~%-33.33333% анемия
~%50% гиперпигментация крупных складок и ареол
~%-33.33333% запоры
~%-33.33333% анорексия
}

Специфичными показателями в крови для первичного гипокортицизма аутоиммунного генеза является:

{
~%-33.33333% отсутствие кальцинатов в надпочечниках по данным компьютерной томографии
~%-33.33333% высокий уровень длинноцепочечных жирных кислот
~%50% антитела к 21-гидрокселазе (P450c23)
~%50% низкий уровень кортизола и высокий АКТГ

~%-33.33333% высокий уровень гамма-глобулина и М-градиент при электрофорозе белков плазм
}

Аддисонический коллапс:

{
~%50% характеризуется резким снижением кровяного давления вплоть до нулевых цифр
~%50% не устраняется введением только катехоломинов
~%-33.33333% не устраняется внутривенным введением массивных доз кортикостероидов
~%-33.33333% характеризуется резким снижением сахара в крови
~%-33.33333% устраняется введением только катехоломинов
}

Для дифференциальной диагностики глюкостеромы от эктопированного АКТГ синдрома наибольшее значение имеет:

{
~%-33.33333% клиническая симптоматика
~%-33.33333% определение уровня кортизола
~%50% определения уровня АКТГ
~%50% проба с дексаметазоном
~%-33.33333% проба с метопивроном
}

Укажите мероприятия по лечению острой надпочечниковой недостаточности:

{
~%-33.33333% немедленное и массивное введение глюкокортикоидов
~%50% немедленное назначение препаратов с выраженной минералкортикоидной активностью
~%50% регидратационная терапия большим количеством 0,9% раствора хлорида натрия
~%-33.33333% введение калийсодержащих препаратов (из расчета 1,5-2,0 г сухого вещества в первые 3 часа)
~%-33.33333% регидратационная терапия малым количеством 0,9% раствора хлорида натрия
}

Этиологическими факторами вторичного альдостеронизма может быть:

{

~%-33.33333% двусторонняя мелкоузловая гиперплазия коры надпочечников (идиопатический альдостеронизм)
~%50% первичное повышение активности ренина
~%50% нефротический синдром
~%-33.33333% синдром Бартера
~%-33.33333% гиперренимический гиперальдостеранизм
{

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ АКТГ-НЕЗАВИСИМОМ СИНДРОМЕ ИЦЕНКО-КУШИНГА СОПРОВОЖДАЕТСЯ
{
~%33.33333%артериальной гипертензией
~%33.33333%остеопорозом
~%-50%гиперпигментацией кожи и слизистых
~%33.33333%появлением стрий
~%-50% артериальной гипотонией
}

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ КОРТИКОСТЕРОМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
{
~%-50%повышением уровня адренокортикотропного гормона
~%33.33333%снижением уровня адренокортикотропного гормона
~%33.33333%повышением уровня кортизола в сыворотке крови
~%33.33333%повышением суточной экскреции кортизола с мочой
~%-50% понижение суточной экскреции кортизола с мочой
}

ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ГИПОТОНИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СВЯЗАН С УМЕНЬШЕНИЕМ
{
~%33.33333%объема плазмы
~%33.33333%общего количества натрия в организме
~%33.33333%активности сосудистых прессорных факторов
~%-50%общего количества калия и хлора в организме
~%-50% объема крови
}

ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
{
~%33.33333%сильными головными болями

~%33.33333%тошнотой, рвотой
~%33.33333%болями в области сердца, сердцебиением, перебоями в работе сердца
~%-50%ухудшением зрения, вплоть до слепоты
~%-50% отсутствием гипертрофии миокарда
}

НЕЙРОМЫШЕЧНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ

{
~%33.33333%тетанией, судорогами
~%33.33333%мышечной слабостью
~%-50%отсутствием параличей
~%33.33333%парестезией
~%-50% отсутствием парестезий
}

К ПОЧЕЧНЫМ СИМПТОМАМ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ОТНОСЯТСЯ

{
~%33.33333%полиурия
~%-50%полифагия
~%33.33333%никтурия
~%33.33333%умеренная протеинурия
~%-50% полидипсия
}

ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ ХАРАКТЕРНО

{
~%33.33333%резкая головная боль, тошнота, рвота
~%-50%отсутствие тетании, преходящих параличей
~%33.33333%снижение или потеря зрения
~%33.33333%резкое повышение артериального давления (особенно диастолического)
~%-50% отсутствие головной боли
}

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИПОКАЛИЕМИИ НА ФОНЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА

{

~%50%появление зубца U
~%-33.33333% удлинение интервала P-Q
~%50%появление уплощенного или отрицательного зубца T
~%-33.33333% снижение S-T ниже изолинии
~%-33.33333% отсутствие изменений S-T
}

ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

{
~%33.33333%снижением зрения
~%33.33333%слепотой
~%33.33333%кровоизлиянием в сетчатку
~%-50%отеком сетчатки и диска зрительного нерва
~%-50%экзофтальмом
}

К ПРИЗНАКАМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ

{
~%33.33333%увеличение массы тела
~%-50%снижение АД
~%-50%гиперкалиемия
~%33.33333%гипокалиемия
~%33.33333%появление отеков
}

ДЛЯ ВТОРИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА ПОЧЕЧНОГО ГЕНЕЗА НЕ ХАРАКТЕРНО

{
~%33.33333%повышение уровня ренина в плазме крови
~%33.33333%повышение уровня ангиотензина II в плазме крови
~%33.33333%повышение уровня альдостерона в плазме крови
~%-50%снижение уровня ренина в плазме крови
~%-50%повышение кровяного давления
}

ПРИ РАЗВИТИИ АДДИСНИЧЕСКОГО КРИЗА РАЗВИВАЕТСЯ

{
~%-33.33333%увеличение пигментации кожи и слизистых

~%50% резкое увеличение слабости
~%-33.33333% быстрое похудания
~%-33.33333% запоры
~%50% тошнота, рвота
}

Для синдрома Прадера-Вилли характерны
{

~%33.33333% гипогонадизм
~%33.33333% снижение интеллекта
~%-50% полидактилия
~%33.33333% ожирение с первых лет жизни
~%-50% акромегалия
}

Основные мероприятия для выведения пациента из адреналового криза в течение первых суток включают

{
~%33.33333% введение внутривенно 0,9% раствора NaCl и 5%-10% глюкозы
~%-50% введение в/в раствора KCl
~%33.33333% введение гидрокортизона сукцината натрия в/в 100 мг
~%33.33333% введение гидрокортизона ацетата в/м 50-100 мг/кг
~%-50% введение преднизолона внутривенно
}

Чем может осложниться течение болезни Иценко-Кушинга?:

{
~%33.33333% инсультом вследствие артериальной гипертензии
~%33.33333% возникновением сердечной недостаточности
~%-50% гипокортицизмом
~%33.33333% тиреотоксикозом
~%-50% остеопорозом
}

Для болезни Иценко-Кушинга характерно:

{
~%50% положительная большая дексаметазоновая проба
~%-33.33333% одностороннее увеличение надпочечника
~%50% двустороннее увеличение надпочечника
~%-33.33333% положительная малая дексаметазоновая проба
~%-33.33333% склонность к гипотонии

}

Формы ВГН, сопровождающиеся низкорениновой артериальной гипертензией:

{

~%-33.33333%дефект STAR-протеина

~%50% дефицит 11-бета-гидроксилазы

~%-33.33333% дефицит 20,22-десмолазы

~%50% дефицит 17-альфа-гидроксилазы

~%-33.33333% дефицит 21-гидроксилазы

}

//Раздел№4 Патология репродуктивной системы- ИД-3 ОПК-5; ИД-2 ОПК-7; ИД-3 ПК-1; ИД-2 ПК-2

Гинекомастия у мальчиков наблюдается при

{

~%33.33333%синдроме Клайнфельтера

~%33.33333%гиперпролактинемии

~%33.33333%синдроме Каллмана

~%-50%тиреотоксикозе

~%-50%сахарном диабете

}

Причины гиперпролактинемии

{

~%33.33333%пролактинсекретирующая опухоль гипофиза

~%33.33333%первичный гипотиреоз

~%33.33333%внутричерепная гипертензия

~%-50%сахарный диабет

~%-50%гиперинсулинизм

}

Для синдрома Ларона характерны

{

~%33.33333%низкорослость

~%-50%гипогонадизм

~%33.33333 %дефицит соматомедина-С

~%33.33333%повышенный выброс СТГ

~%-50%низкий уровень СТГ

}

Для истинного преждевременного полового созревания характерны следующие симптомы:

{

~%50% ускорение костного возраста

~%50% резкое повышение уровней лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов в крови

~%-33.33333% изменение набора половых хромосом по типу 46,XX/XO

~%-33.33333% гиперплазия одного или двух надпочечников

~%-33.33333% повышение уровня 17-оксипрогестерона в крови

}

Какие исследования проводятся при конституциональной задержке полового развития?

{

~%33.33333%определение костного возраста

~%33.33333%определение уровня гонадотропных гормонов терапии

~%-50% определение гормона роста в крови до и после стимуляции его секреции

~%33.33333%определение половых гормонов терапии

~%-50% определение роста и веса

}

При преждевременном половом созревании центрального генеза в гормональном профиле повышается уровень

{

~%50% ЛГ

~%50% ФСГ

~%-33.33333% СТГ

~%-33.33333% пролактин

~%-33.33333% ТТГ

}

Какие признаки характерны для преждевременного полового созревания по изосексуальному типу?

{

~%33.33333%низкорослость, вызванная ранним закрытием зон роста

~%33.33333%появление вторичных половых признаков у девочек до 8 лет, у мальчиков до 9

~%-50% замедленный рост в детстве

~%-50% позднее появление менструаций у девочек и сперматогенеза у мальчиков

~%33.33333%наличие у девочек гамартромы

}

Конституциональная задержка полового развития

{

~%33.33333% составляет 60–80% от ответов форм задержки полового созревания

~%-50% преобладает у девочек

~%33.33333% преобладает у мальчиков

~%33.33333% чаще носит семейный характер

~%-50% не носит семейный характер

}

//Раздел №5 -Ожирение в детском и подростковом возрасте.: ИД-3 ОПК-5; ИД 3 ОПК6 ;ИД-2 ОПК-7; ИД-3 ПК-1.

САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ФОРМОЙ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

{

~%-33.33333% гипоталамическое ожирение

~%-33.33333% эндокринное ожирение

~%50% конституционально-экзогенное ожирение

~%-33.33333% наследственное ожирение

~%50% избыточное поступление калорий с пищей

}

Удельный вес экзогенно-конституционального ожирения по отношению к другим формам составляет

{

~%-33.33333% /30%

~%-33.33333% более /55%

~%50% более /95%

~%-33.33333% /15-20%

~%50% /100% и более

}

Синтезу и отложению жира в депо способствует

{

~%-33.33333% соматотропный гормон

~%-33.33333% кортизол

~%50% инсулин

~%-33.33333% эстрадиол

~%50% эстрогены

}

Пищевой центр располагается в

{

~%50% гипоталамусе

~%-33.33333% гипофизе

~%-33.33333% ретикулярной формации

~%-33.33333% среднем мозге

~%50% гипоталамическое ядро

}

Рост адипоцитов происходит пропорционально употреблению пищи в

{

~%-33.33333% в 1 и 2 триместрах беременности

~%50% в первые годы жизни

~%-33.33333% в пубертатный период

~%-33.33333% начиная с 18 лет

~%50% начиная с эмбрионального развития

}

Основной эффект лептина заключается в

{

~%50% стимулирующем действии на центр голода

~%-33.33333% стимуляции липазы

~%-33.33333% функция остается в пределах нормы

~%-33.33333% повышает продукцию инсулина

~%50% стимулирует утилизацию глюкозы

}

Функция щитовидной железы при ожирении

{

~%-33.33333% повышается

~%50% снижается

~%-33.33333% функция остается в пределах нормы

~%-33.33333% отмечается высокий уровень ТЗ

~%50% отмечается высокий уровень ТТГ

}

Для 1 степени ожирения характерно увеличение массы тела на

{

~%50% \15-20%

~%-33.33333% \20-30%

~%-33.33333% \10-15%
~%-33.33333% \30-40%
~%50% \15-29%
}

Для 3 степени ожирения характерно увеличение массы тела на
{
~%-33.33333% \40-60%
~%50%\50-99%
~%-33.33333% более\80%
~%-33.33333% более \100%
~%50% до \100%
}

Для 2 степени ожирения характерен ИМТ
{
~%-33.33333% 25,0-29,9 кг/м²
~%-33.33333% более 40 кг/м²
~%-33.33333% 35,0-39,9 кг/м²
~%50% 30,0-34,9 кг/м²
~%50% 35,0-40,0 кг/м²
}

Тип распределения жировой ткани характеризуется показателем
{
~%50% объем талии/объем бедер
~%-33.33333% объем бедер/объем талии
~%-33.33333% индекс массы тела
~%-33.33333% индекс Кеттле
~%50% отношение окружностей талии и бедер
}

Состояние иммунной системы при ожирении характеризуется
{
~%50% иммунодепрессией
~%-33.33333% активацией Т- и В-лимфоцитов
~%-33.33333% подавлением Т-супрессоров, активацией Т-хелперов
~%50% усиление пролиферации гранулоцитов
~%-33.33333% пониженная экспрессия генов-мишеней
}

Для адипозо-генитальной дистрофии характерно

- {
- ~%50% распределение подкожно-жировой клетчатки по женскому типу, сухость кожи, депигментированные пятна, гипогенитализм, отсутствие вторичных половых признаков
- ~%-33.33333% распределение подкожно-жировой клетчатки равномерное, сухость кожи, гипогенитализм, отсутствие вторичных половых признаков
- ~%-33.33333% распределение подкожно-жировой клетчатки по женскому типу, депигментированные пятна, половое развитие не страдает
- ~%-33.33333% распределение подкожно-животно клетчатки по мужскому типу, депигментированные пятна
- ~%50% ожирение по гиноидному типу и отставание в половом развитии
- }

Сочетание избыточной массы тела, цианотических и множественных стрий характерно для

- {
- ~%50% адипозо-генитальной дистрофии
- ~%-33.33333% экзогенно-конституционального ожирения
- ~%50% наследственных форм ожирения
- ~%-33.33333% синдрома Иценко-Кушинга
- ~%-33.33333% гипотиреоза
- }

Методами оценки состава тела являются

- {
- ~%33.33333%антропометрические
- ~%33.33333%биоимпедансометрия
- ~%-50%исследование основного обмена
- ~%33.33333%измерение общей электрической проводимости тела
- ~%-50%Денситометрия
- }

К синдромальным формам ожирения относят

- {
- ~%-50%синдром Рассела-Сильвера
- ~%33.33333%синдром Прадера-Вилли
- ~%33.33333%синдром Лоуренса-Муна-Барде-Бидля
- ~%33.33333%синдром Кохена
- ~%-50%синдром Корнели де Ланге
- }

Ятрогенное ожирение может быть вызвано

- {
- ~%33.33333%длительным приемом глюкокортикоидов
- ~%-50%чрезмерным употреблением животных жиров
- ~%33.33333%длительным приемом нейролептиков
- ~%33.33333%длительным приемом антидепрессантов
- ~%-50%прием гормональных контрацептивов
- }

К методам оценки фактического питания относятся

- {
- ~%50%анкетно-опросные
- ~%-33.33333%весовые
- ~%-33.33333%антропометрические
- ~%50%ретроспективные
- ~%-33.33333%расчетные
- }

Биохимическими маркерами метаболического статуса являются

- {
- ~%33.33333%общий анализ крови
- ~%33.33333%протеинограмма
- ~%33.33333%липидограмма
- ~%-50%гормональный профиль
- ~%-50%маркеры инсулинорезистентности
- }

Что относится к принципам рационального питания

- {
- ~%-33.33333%соответствие энергетической ценности рациона суточным энерготратам и содержания пищевых веществ в рационе физиологическим потребностям организма
- ~%-33.33333%сбалансированность пищевых веществ с учетом калорийности в рационе
- ~%-33.33333%соблюдение режима питания
- ~%50%разнообразие пищевых продуктов и блюд в рационе
- ~%50%контроль антропометрических показателей
- }

//Раздел№6 - Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы.:ИД-3 ОПК-5; ИД-2 ОПК-7; ИД-2 ПК-2; ИД 3 ПК3

В РЕЗУЛЬТАТЕ СИНДРОМА ШИЕНА-СИММОНДСА РАЗВИВАЕТСЯ:

{
~%33.33333%парциальный гипопитуитаризм
~%33.33333%пангипопитуитаризм
~%-50% гипофизарный нанизм
~%33.33333%гипоталамо-гипофизарная недостаточность
~%-50% гигантизм
}

ДЛЯ АКРОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРНО:

{
~%33.33333%нарушение углеводного обмена
~%33.33333%диспропорциональный рост костей скелета
~%-50% нарушение минерального обмена
~%33.33333%гипертрофия и гиперплазия внутренних органов
~%-50% нарушение питания
}

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ АКРОМЕГАЛИИ ТИПИЧНЫ:

{
~%33.33333%головные боли и изменения внешности
~%33.33333%симптоматический сахарный диабет
~%33.33333%развитие новообразований
~%-50% отсутствие изменений со стороны костной ткани
~%-50% нормальные размеры внутренних органов
}

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ АКРОМЕГАЛИИ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

{
~%50% тяжестью сердечно-сосудистой патологии
~%-33.33333% степенью изменения внешности
~%50% наличием хиазмального синдрома
~%-33.33333% тяжестью течения симптоматического сахарного диабета
~%-33.33333% размерами внутренних органов
}

ДЛЯ СИНДРОМА КИАРИ-ФРОММЕЛЯ ХАРАКТЕРНО:

{
~%33.33333%лакторея
~%-50% гипокортицизм
~%33.33333%аменорея
~%33.33333%гипоплазия половых органов
~%-50% повышение артериального давления
}

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНОСТИ ПРИ АКРОМЕГАЛИИ ВКЛЮЧАЮТ:

{
~%33.33333%прогнатизм
~%-50% микроглосию
~%33.33333%диастемы
~%33.33333%огрубление черт лица
~%-50% низкий рост
}

К ГОРМОНАЛЬНО-НЕАКТИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ГИПОФИЗА ОТНОСЯТСЯ:

{
~%33.33333%краниофарингиома
~%-50% соматостатинома
~%33.33333%гемангиома
~%33.33333%глиома
~%-50% пролактинома
}

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА ПРИ ГОРМОНАЛЬНО-НЕАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ГИПОФИЗА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

{
~%33.33333%хиазмальный синдром
~%33.33333%паралич черепно-мозговых нервов
~%-50% гипосмию
~%33.33333%головную боль, тошноту, рвоту
~%-50% судороги
}

ДЛЯ СОМАТОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО:

{
~%33.33333%отставание роста
~%-50% прогрессирующее снижение массы тела

~%50% своевременное половое развитие
~%33.33333% мелкие черты лица
~%33.33333% гипогонадизм
}

В РАЗВИТИИ АКРОМЕГАЛИИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ:

{
~%33.33333% опухоль гипоталамуса
~%33.33333% деструктивные изменения гипофиза
~%50% краниофарингиома
~%33.33333% увеличение метаболических эффектов гормона роста
~%50% кортикостерома
}

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГОРМОНАЛЬНО НЕАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСИТСЯ:

{
~%33.33333% несахарный диабет
~%33.33333% хиазмальный синдром
~%33.33333% аденогипофизарная недостаточность
~%50% артериальная гипертензия
~%50% катехоламиновые кризы
}

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМии ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

{
~%33.33333% МРТ гипофиза
~%33.33333% проба с церукалом
~%33.33333% проба с парлоделом
~%50% рентген головного мозга
~%50% проба с дексаметазоном
}

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ГИПОПИТУИТАРИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ:

{
~%33.33333% опухоли
~%33.33333% синдром Шиена-Симмондса
~%33.33333% черепно-мозговая травма
~%50% тяжелая анемия
~%50% гипертиреоз
}

}

ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПАНГИПОПИТУИТАРИЗМА ХАРАКТЕРНО:

{

- ~%50% медленно прогрессирующее течение (несколько лет)
- ~%50% снижение массы тела, уменьшение внутренних органов в объеме и атрофия мышц
- ~%-33.33333% галакторрея в послеродовом периоде
- ~%-33.33333% повышение массы тела
- ~%-33.33333% быстро прогрессирующее течение (1 месяц)

}

ДЛЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ АКРОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРНО:

{

- ~%33.33333% увеличение размеров внутренних органов
- ~%33.33333% развитие функциональной недостаточности увеличенных органов
- ~%33.33333% увеличение количества доброкачественных и злокачественных новообразований
- ~%-50% развитие отеков
- ~%-50% увеличение массы тела

}

ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ АКРОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРНА:

{

- ~%33.33333% артериальная гипертензия
- ~%33.33333% гипертоническая миокардиодистрофия
- ~%33.33333% дилатационная миокардиодистрофия
- ~%-50% дислипотеинемия
- ~%-50% артериальная гипотония

}

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА АКРОМЕГАЛИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ:

{

- ~%33.33333% Магнитно-резонансной томографии
- ~%-50% стандартный тест толерантности к углеводам
- ~%33.33333% определение базового уровня ИФР
- ~%33.33333% рентгенография костей
- ~%-50% глюкозотолерантный тест

}

РЕМИССИИ АКРОМЕГАЛИИ СООТВЕТСТВУЕТ:

{

- ~%50% ликвидация автономной гиперпродукции гормона роста
- ~%50% нормализация уровня ИФР-1 в крови
- ~%-33.33333% нормальные показатели орального глюкозотолерантного теста
- ~%-33.33333% компенсация симптоматического сахарного диабета
- ~%-33.33333% нормализация артериального давления

}

ДЛЯ МАКРОАДЕНОМЫ АДЕНОГИПОФИЗА ХАРАКТЕРНО:

{

- ~%33.33333%сдавление окружающих структур опухолью
- ~%33.33333%нарушение зрения
- ~%-50% доброкачественное течение
- ~%33.33333%головные боли
- ~%-50% повышение глюкозы в крови

}

ДЛЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ХАРАКТЕРНА ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ:

{

- ~%33.33333%женщин
- ~%33.33333%лиц в возрасте 20-40 лет
- ~%-50% базофильных аденом гипофиза
- ~%33.33333%встречается реже ятрогенного гиперкортизолизма
- ~%-50% лиц в возрасте 50-70 лет

}

ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ У МУЖЧИН ХАРАКТЕРНО:

{

- ~%33.33333%клиника эректильной дисфункции
- ~%33.33333%бесплодие
- ~%-50% обязательное наличие истинной гинекомастии
- ~%33.33333%отсутствие галактореи
- ~%-50% гипертиреоз

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОМАТОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕОБХОДИМЫ:

{
~%33.33333%данные антропометрии
~%33.33333%данные рентгенологического исследования (костный возраст)
~%33.33333%подтверждение дефицита гормона роста
~%-50% глюкозотолерантный тест
~%-50% подтверждение дефицита витамина Д
}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЁННОГО НЕФРОГЕННОГО НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ:

{
~%33.33333%адекватную пероральную регидратацию
~%33.33333%тиазиды и амилорид
~%33.33333%ограничение солевой нагрузки
~%-50% ограничение физической активности
~%-50% введение инсулина
}

Выделите возможные причины развития церебрально-гипофизарного нанизма

{
~%33.33333%снижение секреции гормона роста
~%33.33333%недостаток соматомедина
~%33.33333%синдром пустого турецкого седла
~%-50%тяжелые соматические заболевания
~%-50%инфекции
}

Какие лекарственные пробы проводятся для определения стимулированной секреции гормона роста?

{
~%33.33333%с клофелином
~%-50%с анаприлином
~%33.33333%с инсулином
~%33.33333%с L-ДОПА
~%-50%с глюкагоном
}

При диагностике СТГ-дефицита проводятся следующие исследования

{
~%33.33333%определение уровней СТГ и ИФР-1
~%33.33333%рентгенография кистей рук
}

~%33.33333%определение кариотипа
~%-50%десаметазоновая проба
~%-50%проба с клофелином
}

Осложнениями после транскраниального удаления краниофарингиомы являются
{
~%33.33333%центральный несахарный диабет
~%-50%гипергонадотропный гипогонадизм
~%33.33333%СТГ-дефицит
~%-50%аутосомный тиреоидит
~%33.33333%вторичный гипокортицизм
}

Несахарный диабет центрального генеза необходимо дифференцировать с
{
~%33.33333%психогенной полидипсией
~%33.33333%сахарным диабетом
~%-50%конституционально-экзогенным ожирением
~%-50%гиперинсулинизмом
~%33.33333%нефрогенным несахарным диабетом
}